

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Pratique du secourisme pour la prévention des accidents cardio-vasculaires

Module II : L'Éducation à la Santé — Le secourisme

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise l'ensemble des compétences de secourisme (PAS, DAEA, PLS) dans des situations complexes, réalistes et évolutives, exigeant un raisonnement clinique rigoureux et une prise de décision autonome.

EXERCICE 1 Arrêt cardiaque : qualité de la RCP, défibrillation et travail d'équipe

Un homme de 58 ans s'effondre brutalement sur un terrain de sport. Vous êtes témoin unique pendant les 3 premières minutes, puis rejoint par un secouriste titulaire du PSC1 apportant un DAE semi-automatique. La victime est inconsciente, ne respire pas (respiration agonalique), sans pouls carotidien palpable.

1. Justifiez physiologiquement pourquoi la reconnaissance de la « respiration agonalique » ne doit pas retarder le début des compressions thoraciques. Précisez le délai maximal recommandé pour vérifier la respiration.
2. En tant que témoin unique, détaillez la séquence exacte des 5 premières minutes de prise en charge (alertes, RCP, DAE) en intégrant les critères de qualité de la RCP haute performance (fréquence, profondeur, relâchement, interruptions). Calculez le nombre théorique de cycles 30/2 réalisés en 2 minutes si les interruptions sont minimisées (< 10 s).
3. À l'arrivée du second secouriste avec le DAE, décrivez la chorégraphie précise du relais (transition 1 secouriste → 2 secouristes) sans interrompre les compressions plus de 5 secondes. Quel rôle spécifique le second secouriste assume-t-il pendant l'analyse et la charge du DAE ?
4. Le DAE recommande un choc (VF). Après le choc, l'appareil annonce « Pas de choc conseillé » puis « Continuer la RCP ». Expliquez la conduite à tenir immédiate et l'intérêt hémodynamique de reprendre les compressions avant toute réévaluation du rythme ou de la respiration.
5. Analyse critique : Pourquoi l'hyperventilation (volume ou fréquence excessifs) est-elle délétère lors de l'arrêt cardiaque ? Reliez votre réponse à la pression intrathoracique et au retour veineux.

EXERCICE 2 Étouffement total : biomécanique des manœuvres et cas particuliers

1. Comparez, dans un tableau structuré, la prise en charge de l'étouffement total chez : l'adulte/'enfant > 1 an, la femme enceinte (ou obèse), le nourrisson < 1 an. Colonnes :

Manœuvre de 1^{er} intention, Manœuvre de 2^e intention si échec, Positionnement de la victime, Contre-indication absolue et justification anatomique.

2. Pour la femme enceinte, expliquez pourquoi la compression abdominale (Heimlich) est formellement contre-indiquée. Décrivez la technique alternative (compressions thoraciques) : position des mains, direction de la poussée, nombre de compressions par série.
3. Un nourrisson de 8 mois présente un étouffement total. Après 5 claques dorsales inefficaces, vous réalisez 5 compressions thoraciques. La victime devient inconsciente. Détaillez la conduite à tenir immédiate : alerte, début de RCP, particularité de l'ouverture des voies aériennes (recherche corps étranger) avant insufflations.
4. Question ouverte : Un témoin vous rapporte avoir « réussi » à déloger un aliment chez un adulte conscient en lui donnant de violents coups dans le dos alors qu'il était debout. Analysez les risques majeurs de cette pratique non codifiée (migration du corps étranger, lésions vertébrales, retard à la manœuvre efficace) et argumentez sur la nécessité de respecter l'algorithme officiel.

EXERCICE 3 Perte de connaissance : diagnostic différentiel, PLS et surveillance dynamique

Une jeune femme de 22 ans est trouvée allongée au sol en discothèque, musique très forte. Elle ne répond pas à l'appel ni à la stimulation tactile (pincement trapèze), mais présente une ventilation abdominale efficace (FR = 14/min, amplitude correcte) et un pouls radial palpable à 80 bpm, régulier. La peau est pâle, moite, pupilles isochores, réactives.

1. Établissez le diagnostic de situation (Perte de Connaissance simple vs Arrêt Cardiaque vs Malaise vagal non syncopal). Justifiez chaque item par les signes cliniques pertinents (niveau de conscience, ventilation, circulation).
2. Décrivez pas à pas la mise en PLS (côté droit) en insistant sur : la gestion du membre supérieur « pivot », l'ouverture et le maintien des voies aériennes (index-menton), l'angle de flexion de la hanche/genou pour la stabilité, et la surveillance continue des paramètres vitaux.
3. La victime vomit soudainement en PLS. Décrivez la manœuvre d'urgence pour éviter l'inhalation (pivot de la tête, aspiration buccale) sans sortir la victime de la PLS. Que faites-vous immédiatement après ?
4. Au bout de 10 minutes, la ventilation devient bruyante (ronflement), la FR chute à 6/min, le pouls radial devient impalpable (carotidien présent à 40 bpm). Analysez l'évolution : quel diagnostic redoutez-vous ? Quelle est la conduite à tenir immédiate (position, gestes, alerte) ? Justifiez le passage de la PLS à la RCP.
5. Dimension relationnelle : La victime reprend conscience (réorientation confusionnelle) avant l'arrivée des secours. Elle est anxieuse, ne comprend pas ce qui s'est

passé, refuse l'hôpital. Élaborez une argumentation empathique et ferme pour convaincre de l'évacuation médicale, en citant les risques de récurrence et les causes sous-jacentes potentielles (toxicologie, cardiologie, neurologie).

EXERCICE 4 Synthèse : Gestion multi-victimes et priorisation (Tri simple)

Vous êtes seul, premier témoin sur un accident de la route : 3 victimes. Victime A (conducteur) : inconsciente, ne respire pas, coincée dans le véhicule (fumée moteur). Victime B (passager) : conscient, se plaint de douleurs thoraciques, respire difficilement, ne peut bouger la jambe droite. Victime C (piéton) : inconscient, respire normalement (FR 16), pouls carotidien présent, saignement abondant cuisse gauche.

1. Appliquez la méthode de tri simple (URGENCE RELATIVE / URGENCE ABSOLUE / DÉCÉDÉ / URGENCE EXTRÊME) pour classer les 3 victimes. Justifiez chaque classe par les fonctions vitales compromises.
2. En attendant les secours (ETA 8 min), vous ne pouvez intervenir physiquement que sur une victime à la fois. Déterminez l'ordre d'intervention prioritaire et détaillez les gestes salvateurs réalisés sur chacune dans l'ordre choisi (ex : extraction urgence extrême, garrot, PLS, alerte enrichie).
3. Pour la Victime A (Arrêt Cardiaque + Danger incendie), l'extraction est risquée et prendrait 3 min. Le DAE est dans votre véhicule à 50 m. Discutez le dilemme éthique et technique : RCP sur place dans l'habitacle (inefficace) vs Extraction sans RCP vs RCP pendant extraction. Quelle décision prenez-vous et pourquoi ?
4. Bilan : Après intervention des secours, la Victime C survit grâce au garrot posé à temps. La Victime A est décédée. La Victime B est opérée (fracture fémur + contusion pulmonaire). Rédigez un compte-rendu d'intervention structuré (Chronologie, Gestes effectués, Constatations, Transmission aux secours) tel qu'exigé en formation PSC1/DAEA.